BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NẤM THANH QUẢN

Mã đề xuất CS-TMH-11; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

Mã ICD xác nhận theo vị trí và căn nguyên; không gán J06.0-B49 như một mã thống nhất khi chưa có chẩn đoán.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

*Khai thác tiền sử: Người bệnh có khàn tiếng, nói khó không?Bệnhcó ngứa họng không?Người bệnh có ho không? ho nhiểu hay ít có kéo dài không? ho có đờm không? Bệnh nhân có khó thở không?Bệnh có đau họng không?Tiền sử bệnh: thường xuyên làm việc trong môi trường khối bụi ô nhiễm, sử dụng kháng sinh, corticoid không theo chỉ định, có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

*Khám: Quan sát thể trạng người bệnh, quan sát da niêm, quan sát tình trạng hô hấp, quan sát thành họng có đỏ có giả mạc không

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1.Bệnh đau họng do viêm

2.2.Người bệnh khan tiếng do ho nhiểu

2.3.Nguy cơ xảy ra biến chứng do điều trị không hiệu quả

2.4.Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Giảm đau cho người bệnh

3.2.Giảm khan tiếng,

3.3.Giảm nguy xảy ra biến chứng

3.4Người bệnh thiếu kiến thức

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Giảm đau cho người bệnh

- Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh,

- Theo dõi tình trạng đau , tính chất đau, cường độ đau

Vệ sinh miệng và nước uống theo khả năng nuốt, lựa chọn nhiệt độ dung nạp; không coi kiêng nước lạnh là biện pháp điều trị nấm.

4.2.Giảm khan tiếng,

Nghỉ giọng phù hợp, tránh nói gắng sức/khói thuốc; thuốc giảm ho hoặc khí dung chỉ khi có chỉ định, không dùng bắt buộc.

4.3.Giảm nguy xảy ra biến chứng

Theo dõi giọng, đau, nuốt và hô hấp; thở rít/khó thở cần hỗ trợ cấp cứu và báo bác sĩ. Nội soi và xét nghiệm xác định nấm/loại trừ bệnh khác theo chuyên khoa.

Theo dõi sốt, sinh hiệu và tình trạng toàn thân; bạch cầu tăng đơn độc không đủ kết luận nhiễm trùng huyết. Thuốc kháng nấm theo y lệnh, theo dõi tác dụng bất lợi và tương tác.

4.4.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

Tránh thuốc lá/rượu, dùng thuốc đúng kế hoạch; không tự ngừng corticoid hay thuốc ức chế miễn dịch. Nếu dùng corticoid hít, hướng dẫn kỹ thuật và vệ sinh miệng phù hợp.

- Thường xuyên vệ sinh rang miệng , súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc họng

- Ăn thức ăn mềm dễ tiêu

- Thực hiện thuốc theo lệnh của bác sĩ

5. Đánh giá

Người bệnh khỏe, không để lại biến chứng, ăn uống được

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……